

Mujer de 58 años con sangrado vaginal tras la menopausia

Caso clínico de Ginecología · Nivel: estudiante de grado · Código: GIN-04

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Rosa A. S.
Edad	58 años
Profesión	Jubilada
Estado civil	Viuda
Fórmula obstétrica	G1 P1 A0
Edad gestacional	Posmenopáusica (menopausia a los 52 años)

Motivo de consulta

Pequeño sangrado vaginal después de 6 años sin reglas.

Antecedentes

Personales	Obesidad (IMC 34). Hipertensión. Diabetes tipo 2. No toma terapia hormonal.
Familiares	Madre con cáncer de mama.
Gineco-obstétricos	Menopausia a los 52 años. Un parto. Menarquia precoz a los 11 años. No anticoncepción hormonal previa relevante.
Hábitos	No tabaco.

Historia de la enfermedad actual

Refiere manchado vaginal escaso, intermitente, desde hace 3 semanas, 6 años después de la menopausia. No dolor. No flujo maloliente. No pérdida de peso ni síntomas urinarios o digestivos llamativos. No relaciones sexuales recientes que lo justifiquen. Está preocupada porque "ya no debería sangrar".

Exploración física

TA 142/86 mmHg. IMC 34 (obesidad). Especuloscopia: vagina con signos de atrofia, cérvix sin lesiones visibles, escaso sangrado que parece proceder de cavidad uterina. Tacto bimanual: útero de tamaño normal, móvil, no doloroso; anejos no palpables.

Pruebas complementarias disponibles

- Ecografía transvaginal: endometrio engrosado y heterogéneo de 12 mm (en posmenopáusica sin THS el límite suele ser $\leq 4\text{-}5$ mm).
- Biopsia endometrial / histeroscopia con biopsia: adenocarcinoma de endometrio (endometriode) — resultado anatomopatológico.
- Citología cervical: sin lesiones.

- Analítica general normal. Estudio de extensión solicitado (RM pélvica) tras el diagnóstico.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Rosa, 58 años, llevas 6 años sin la regla y de repente has empezado a manchar un poco. Estás preocupada porque sabes que a tu edad eso no es normal. Hablas con naturalidad. Si preguntan, cuentas que tienes azúcar (diabetes), tensión alta y que pesas de más. No tomas hormonas. No tienes dolor. Quieres saber si es algo malo.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Carcinoma de endometrio. Todo sangrado posmenopáusico es cáncer de endometrio mientras no se demuestre lo contrario; aquí, endometrio engrosado (12 mm) + biopsia con adenocarcinoma endometriode. Factores de riesgo: obesidad, diabetes, HTA, menarquia precoz, menopausia tardía.

Diagnóstico diferencial

- Atrofia endometrial/vaginal (causa más frecuente de sangrado posmenopáusico)
- Pólipo endometrial
- Hiperplasia endometrial
- Patología cervical
- Sangrado por terapia hormonal

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Confirmar que es sangrado posmenopáusico (clave de alarma).
- Factores de riesgo de cáncer de endometrio: obesidad, diabetes, HTA, nuliparidad, menopausia tardía, tamoxifeno, THS sólo con estrógenos.
- Descartar otras fuentes de sangrado (cérvix, vagina, urinario, rectal).

Pruebas que debería solicitar

- Ecografía transvaginal (grosor endometrial).
- Biopsia endometrial / histeroscopia con biopsia (DIAGNÓSTICO definitivo).
- Citología cervical.
- Tras el diagnóstico: estudio de extensión (RM pélvica, valoración por oncología).

Manejo / tratamiento correcto

Derivación y estadificación. El tratamiento principal del carcinoma de endometrio en estadios iniciales es quirúrgico: histerectomía total con doble anexectomía ± estadificación ganglionar. Tratamiento adyuvante (radioterapia/quimioterapia) según estadio y factores de riesgo. Manejo por unidad de ginecología oncológica. Control de comorbilidades.

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Reconoce el sangrado posmenopáusico como signo de alarma	20
Identifica los factores de riesgo de cáncer de endometrio	15
Solicita ecografía transvaginal e interpreta el grosor endometrial	15
Indica biopsia/histeroscopia como prueba diagnóstica definitiva	25
Diagnostica carcinoma de endometrio y deriva para estadificación	15
Conoce el tratamiento quirúrgico de base (histerectomía + anexectomía)	10
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Atribuir el sangrado a la atrofia sin biopsiar (no descartar cáncer).
- Quedarse sólo con la ecografía sin obtener histología.
- No reconocer el perfil de riesgo (obesidad-diabetes-HTA).
- Retrasar la derivación a ginecología oncológica.